Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO / IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE	
SERVICIO DE SALUD / SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO / DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
UNIDAD ASISTENCIAL RESPONSABLE / UNITAT ASSISTENCIAL RESPONSABLE	Servicio de Urgencia Hospitalaria
SERVICIO / SERVEI	URGENCIAS
NÚM.DE EPISODIO / NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO / DATA D'INGRÉS	01/09/2021
FECHA Y HORA DE ALTA / DATA I HORA D'ALTA	01/09/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT			
PRIMER APELLIDO / PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO / SEGON COGNOM			
NOMBRE / NOM			
CIP DE LA CA / CIP DE LA CA		Nº Hª CLÍNICA / Nº Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO / CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS / CODI SNS	
SEXO / SEXE	Mujer	F. NACIMIENTO / D. NAIXIMENT	
DIRECCIÓN / DIRECCIÓ			

Datos generales del paciente / Dades generals del pacient

Procedencia / Procedència: PARTICULAR

Motivo de la atención / Motiu de l'atenció: CODICT HZXDXTU

Antecedentes / Antecedents:

*RAM: niega
*Antecedentes personales:
-No FRCV
-Elevación hemidiafragma derecho.
-Portadora de BIPAP.
*Fármacos de uso habitual: seguril ocasional, inhaladores.
Social: vive con el marido. Independiente para ABVD. Barthel100. Rankin 0

** Dificil anamnesis por barrera idiomática con el marino (frances y conversación telefónica) y por estado ebrio de la paciente.

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual:

Mujer de 82a remitida por médico de atención continuada 00.55H, avisa el marido porque nota que no habla bien y le cuesta moverla. La paciente refiere "torpeza" en hemicuerpo izquierdo. Ha consumido dos copas de vino blanco según cuenta. No dolor torácico. Afebril. Presenta hematoma en dorso mano derecho y en brazo izquierdo, al parecer ha caido pero no sabe especificar. Marido refiere que la última vez que la vió bien fue despues de la cena, sobre las 21h.

Exploración física / Exploració física:

Constantes vitales: glucemia 108 mg/dl; TA: 142/57 mmHg; Tª: 36.9 ºC (Timpánica); FC: 50 lat/min; Sat. O2: 100 %;
AP: mvc sin ruidos sobreañadidos.
MMII: no edema.
Exploración Neurológica: alerta, orientada en persona, falla mes. MOES conservados. No hemianopsias por confrontación. Hemiparesia izda 4/5 en MS y 4-/5 en MI. Refiere hipoestesia al pinchazo. No dismetrias d-n. EXtinción no valorable. Disartria moderada. NIHSS 5 puntos.
AC: tonos regulares, sin soplos.
Test de los 3 tragos: tose en el segundo

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries:

BIOQUÍMICA
GLUCOSA 117 mg/dL * (70 - 110)
UREA 30 mg/dL (10.0 -- 50.0)
CREATININA 0,66 mg/dL (0,51 - 0,95)
FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI 81,99 ml/min/sup (60.00-200.0)
SODIO 138 mmol/L (134-145)
POTASIO 3,98 mmol/L (3.50-5.00)
CLORO 105 mmol/L * (95-105)
PROTEINA C REACTIVA 6,97 mg/L (1.00-10.0)

Evolución / Evolució:

Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

HEMOGRAMA
T. PROTROMBINA 10,4 seg (9,0 - 13,0)
INDICE DE QUICK 120,0 % (70,0 - 120,0)
ATENCIÓN: Este valor se interpreta como =100%.
INR 0,90 (0,80 - 1,20)
TP RATIO 0,90 (0,80 - 1,20)
TTPA RATIO 0,90 (0,80 - 1,25)
T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 28,3 seg (25,1 - 32.5)
FIBRINOGENO 306,00 mg/dL (200,00 - 400,00)
HEMOGRAMA
HEMATIES 4,31 x 10^6/µL (4,20 - 6,10)
HEMOGLOBINA 13,8 g/dL (12,0 - 18,0)
HEMATOCRITO 40,3 % (37,0 - 52,0)
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 93,6 fL (80 - 94)
LEUCOCITOS 9,70 x 10^3/µL (4,80 - 10,80)
NEUTROFILOS 5,20 x 10^3/µL (1,90 - 8,00)
LINFOCITOS 3,00 x 10^3/µL (0,90 - 5,20)
MONOCITOS 1,30 x 10^3/µL * (0,16 - 1,00)
EOSINOFILOS 0,20 x 10^3/µL (0,00 - 0,80)
BASOFILOS 0,10 x 10^3/µL (0,00 - 0,20)
PLAQUETAS 211 x 10^3/µL (130 - 400)
ECG: Bradicardia sinusal 53 lpm, eje qrs 60º, PR de 200 ms, qrs estrecho con morfología de BIRDHH, onda T invertida en v1-v2, adecuada progresión RS en precordiales, QTC normal.
RX TÓRAX: elevación hemidiafragma derecho.
TC CRÁNEO Y ANGIO-TC: sin sangrado ni lesión isquémica aguda. Oclusión ACI I

Estable en urgencias. CI activado intrahospitalario. No se realiza tratamiento fibrinolítico por tiempo > 4,5h y perfusión no significativa.
Se intenta contactar con el marido para informar de ingreso, sin éxito.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal: ICTUS ISQUEMICO. SD LACUNAR MOTOR PURO

Diagnósticos secundarios / Diagnòstics secundaris: OCLUSION ACI I

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta: Pauto tratamiento
Solicito RM cerebral y sistemático

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta: PASO A HOSPITALIZACIÓN - NEUROLOGIA

Responsable:

Firma digital / Signatura digital:

ADJUNTO

Sección / Secció: URGENCIAS

Fecha / Data:

Fecha creación / Data creació: 01/09/2021